Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

URGÊNCIAS ABDOMINAIS: ABDOME AGUDO

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



APRESENTAÇÃO:

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido Aluno, abdome agudo sempre é um tema recorrente nas provas de Residência. Neste resumo falaremos sobre o abdome agudo de uma forma mais generalizada, mas será a base, a fim de preparar você para os próximos capítulos. Esse é um tema mais denso e complexo, com vários conceitos. Então, se surgir alguma dúvida, veja o nosso livro texto que está bem completo.

@prof.renathapaiva
@estrategiamed
Estratégia MED
/estrategiamed
@estrategiamed
t.me/estrategiamed

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

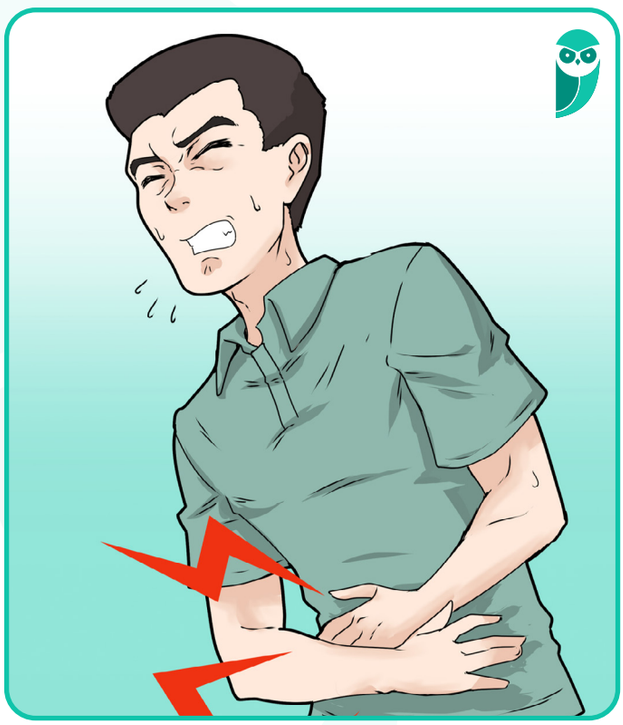
1.0 INTRODUÇÃO 4
2.0 EMBRIOLOGIA DO INTESTINO PRIMITIVO 4
3.0 BASE NEUROLÓGICA DA DOR ABDOMINAL 6
3.1 DOR VISCERAL 6
3.2 DOR PARIETAL OU SOMÁTICA 7
3.3 DOR REFERIDA 8
4.0 AVALIAÇÃO DA DOR ABDOMINAL 9
4.1 ANAMNESE 9
4.2 EXAME FÍSICO 10
5.0 EXAMES COMPLEMENTARES 12
5.1 EXAMES LABORATORIAIS 12
5.2 EXAMES DE IMAGEM 12
6.0 CAUSAS DE ABDOME AGUDO 20
6.1 ABDOME AGUDO CIRÚRGICO 20
6.2 ABDOME AGUDO NÃO CIRÚRGICO 24
7.0 TRATAMENTO DO ABDOME AGUDO 25
8.0 ABDOME AGUDO EM POPULAÇÕES ESPECIAIS 25
8.1 IDOSOS 25
8.2 GESTANTES 26
9.0 PERITONITES 26
9.1 PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA 26
9.2 PERITONITE BACTERIANA SECUNDÁRIA 26
9.3 PERITONITE BACTERIANA TERCIÁRIA 28
10.0 MAPA MENTAL 29
11.0 LISTA DE QUESTÕES 31
12.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 32
13.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 33

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
1.0 INTRODUÇÃO

Abdome agudo: síndrome dolorosa aguda, não traumática, de intensidade variável, que leva o paciente a procurar o serviço de urgência e requer tratamento imediato, seja clínico ou cirúrgico. Se não for tratado, evolui para piora dos sintomas e progressiva deterioração do estado geral.

Para entender os mecanismos responsáveis pela dor, precisamos voltar lá nos primeiros anos de faculdade e relembrar conceitos de embriologia, anatomia e fisiologia. Depois disso, você vai perceber que tudo tem sua explicação na Medicina e que é possível entender o porquê de um sinal ou sintoma e não simplesmente decorá-lo.



CAPÍTULO
2.0 EMBRIOLOGIA DO INTESTINO PRIMITIVO

O intestino primitivo divide-se na 4ª semana de gestação em: anterior, médio e posterior. Cada um originando segmentos do trato gastrointestinal:



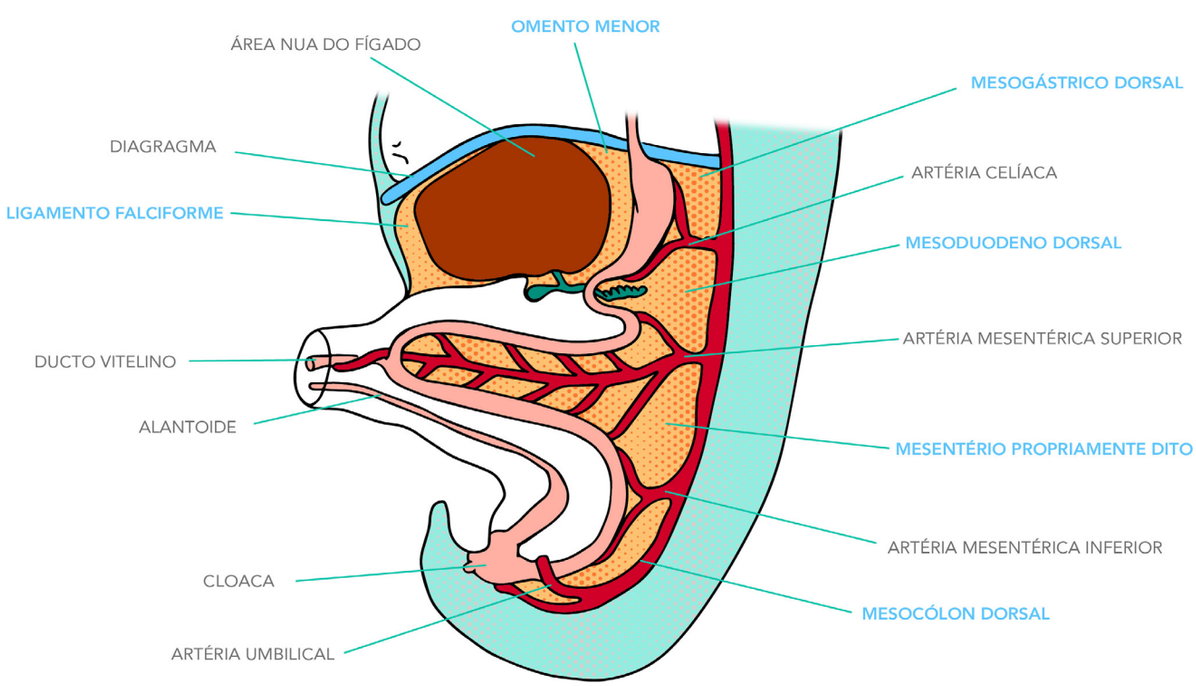
- Intestino anterior: boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas e a metade proximal do duodeno.
- Intestino médio: metade distal do duodeno, jejuno, íleo, cólon ascendente e dois terços do cólon transverso.
- Intestino posterior: terço distal do cólon transverso, cólon descendente, reto e porção superior do canal anal.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

É muito importante saber que a origem dos plexos nervosos responsáveis pela dor visceral e a irrigação intestinal fazem o mesmo caminho embriológico. Desse modo, os órgãos do intestino anterior são irrigados pelo tronco celíaco e inervados pelo gânglio celíaco. Os órgãos do intestino médio são irrigados pela artéria mesentérica superior e pelo gânglio mesentérico superior e, com o mesmo raciocínio, o intestino posterior é irrigado pela artéria mesentérica inferior e inervado pelo gânglio mesentérico inferior.

EMBRIOLOGIA	INERVAÇÃO	IRRIGAÇÃO
Intestino anterior	Plexo celíaco	Tronco celíaco
Intestino médio	Plexo mesentérico superior	Art. Mesentérica superior
Intestino posterior	Plexo mesentérico inferior	Art. Mesentérica inferior

EMBRIOLOGIA DO INTESTINO



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
3.0 BASE NEUROLÓGICA DA DOR ABDOMINAL

Os receptores de dor no abdome, denominados nociceptores, respondem a estímulos mecânicos e químicos. Existem basicamente três tipos de dores abdominais:

3.1 DOR VISCERAL

→ Nociceptores: localizados no parênquima e cápsula dos órgãos sólidos, superfícies serosas, na parede das vísceras ocas e no mesentério.

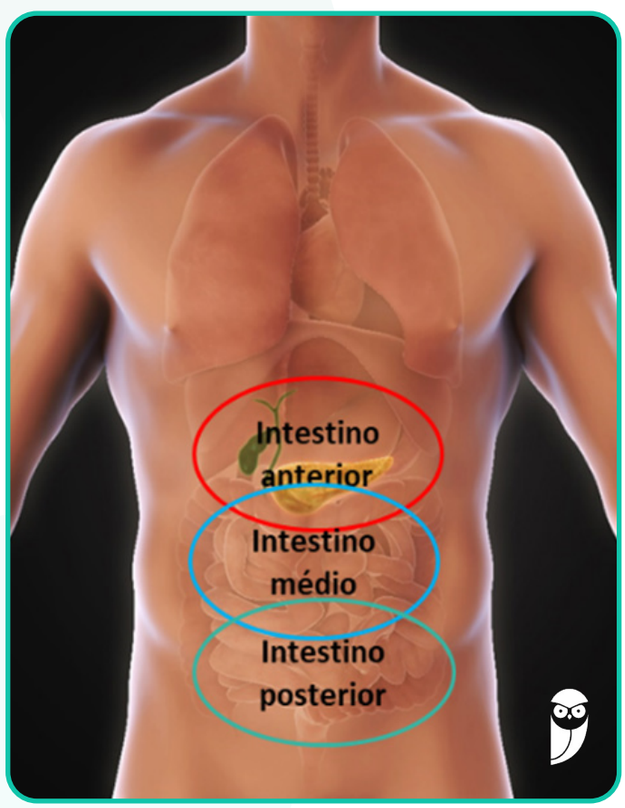
→ Transmitida por fibras aferentes viscerais, que são fibras do sistema nervoso autônomo, não mielinizadas do tipo C de condução lenta.

→ Estímulos: distensão, tração, isquemia, torção, contração rápida e violenta das vísceras.

→ Mal localizada, difusa, lenta, vaga e imprecisa.

Percebida na linha média abdominal, pois as vísceras peritoneais recebem a inervação aferente de ambos os lados da medula espinhal.

→ Exemplo: dor periumbilical na fase inicial da apendicite aguda.



Localização da dor visceral.
Fonte: adaptação do Shutterstock.

A dor proveniente das vísceras abdominais geralmente localiza-se de acordo com a origem embriológica da estrutura acometida:

- Dor visceral de estruturas do intestino anterior: manifesta-se no epigástrio.
- Dor visceral de estruturas do intestino médio: manifesta-se na região periumbilical.
- Dor visceral de estruturas do intestino posterior: manifesta-se na região suprapúbica/hipogástrio.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

EMBRIOLOGIA	INERVAÇÃO	IRRIGAÇÃO	LOCALIZAÇÃO DA DOR
Intestino anterior	Plexo celíaco	Tronco celíaco	Epigástrio
Intestino médio	Plexo mesentérico superior	Art. mesentérica superior	Mesogástrio/ periumbilical
Intestino posterior	Plexo mesentérico inferior	Art. mesentérica inferior	Hipogástrio/suprapúbica

3.2 DOR PARIETAL OU SOMÁTICA

→ Nociceptores: localizados no peritônio parietal e na raiz do mesentério.
→ Transmitida por fibras somáticas mielinizadas do tipo A delta, de condução rápida, para os gânglios da raiz dorsal específicos do mesmo lado e nível dermatomal de origem da dor, mais exatamente localizada nos segmentos de T6 a L1.
→ Estímulos: isquemia, inflamação ou alongamento do peritônio parietal.
→ Aguda, rápida e localizada.
→ Percebida próximo ao ponto onde ocorre a estimulação dolorosa, na parede abdominal.
→ Exemplo: dor da descompressão brusca dolorosa na fossa ilíaca direita da apendicite aguda (sinal de Blumberg).

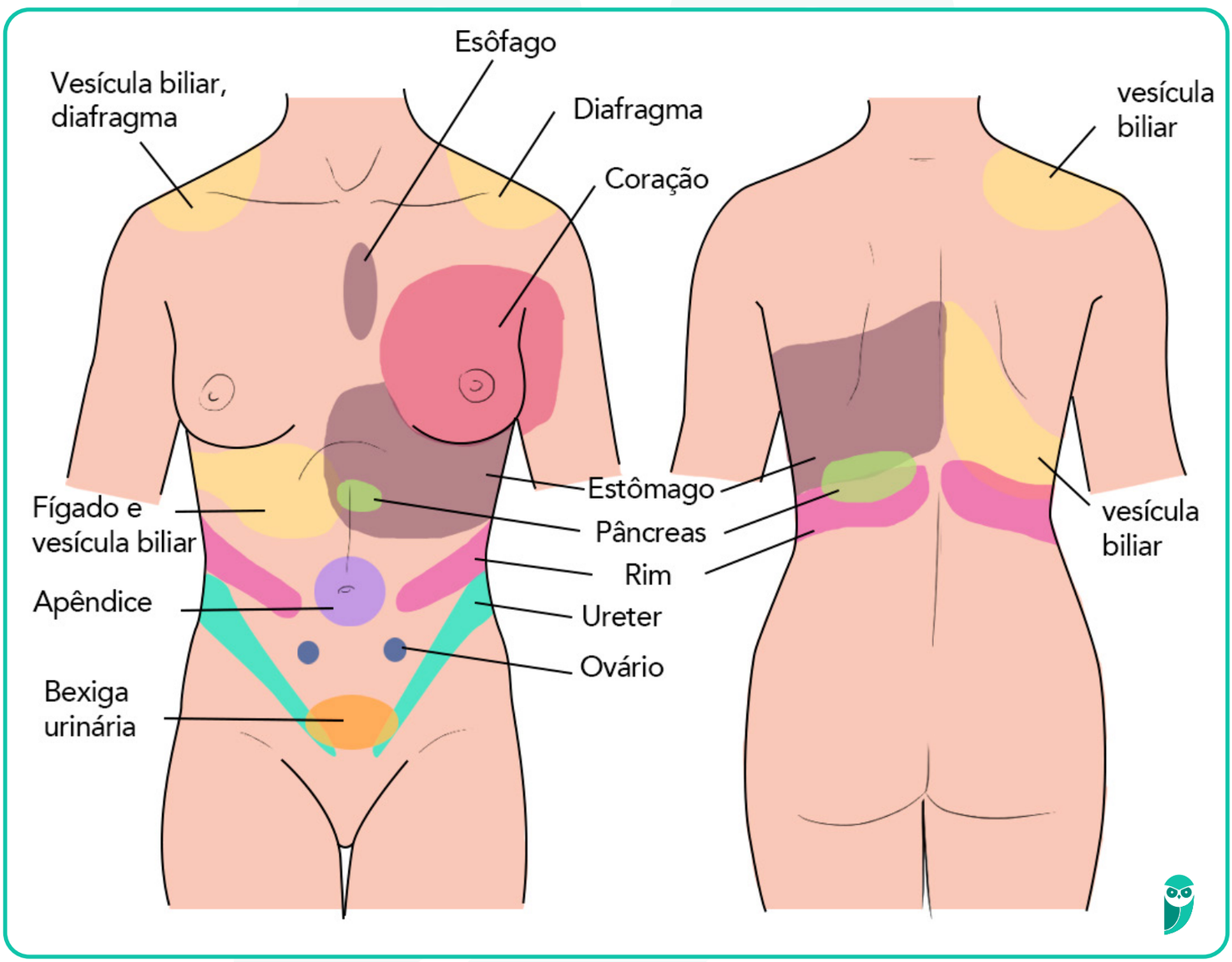
A irritação do peritônio parietal, além da dor, acarreta contratura muscular. Essa pode ser localizada ou generalizada (abdome "em tábua"), dependendo da extensão da irritação. A contratura muscular é explicada pela inervação comum do peritônio parietal e da musculatura abdominal. Quanto mais ácido for o pH ou quanto maior for a concentração de íons K+ do líquido intracavitário, maior será seu poder de irritação peritoneal.

DOR PARIETAL	DOR VISCERAL
Peritônio parietal/pele	Peritônio visceral
Irritação peritoneal	**Distensão**, tração, isquemia etc.
Fibras somáticas	Fibras viscerais (sistema nervosa autônomo - resposta vagal)
Dor localizada, rápida, aguda, bem definida	Dor mal localizada, lenta, difusa, vaga, imprecisa, linha média Resposta vagal: hipotensão, bradicardia, sudorese
Fibras mielinizadas do tipo A – condução rápida	Fibras não mielinizadas do tipo C – condução lenta
Ex.: dor periumbilical (apendicite)	Ex: dor em FID (sinal de Blumberg)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

3.3 DOR REFERIDA

- Dor percebida em um local distante do órgão afetado.
- Geralmente está localizada nos dermátomos cutâneos, compartilhando o mesmo nível da medula espinhal das entradas dos nervos aferentes viscerais.
- Exemplo: as entradas nociceptivas da vesícula biliar entram na medula espinhal em T5 a T10. Assim, a dor da colecistite pode ser percebida na região subescapular ou ombro direito. Da mesma forma, a dor da ureterolitíase pode ser referida no escroto ou grandes lábios.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

LOCALIZAÇÕES E CAUSAS DE DOR REFERIDA
Ombro direito
Fígado Vesícula biliar Hemidiafragma direito
Ombro esquerdo
Cardíaca Cauda do pâncreas Baço Hemidiafragma esquerdo
Escroto e testículos / grandes lábios
Ureter

Fonte: Sabiston, 20ª edição

CAPÍTULO
4.0 AVALIAÇÃO DA DOR ABDOMINAL

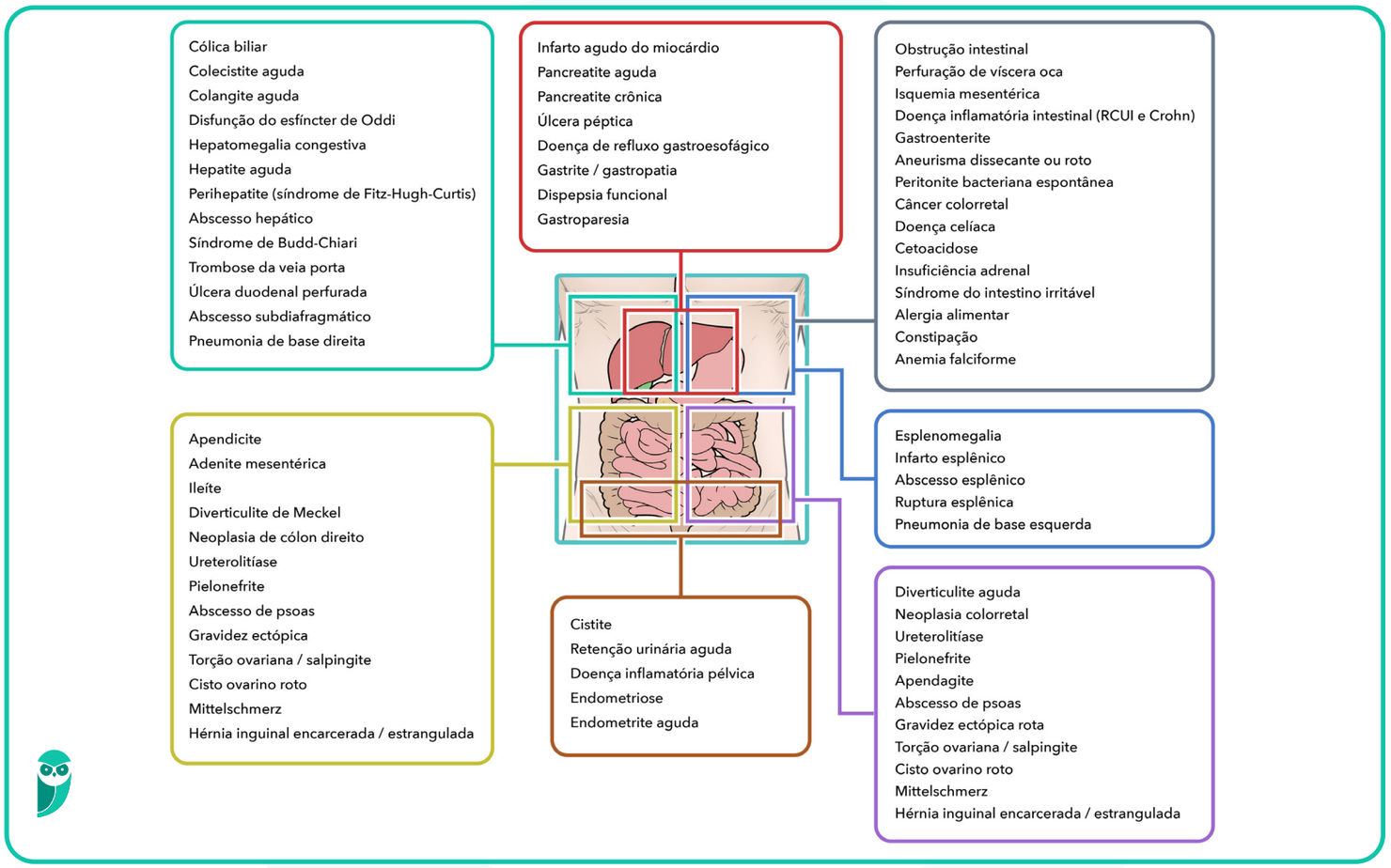
Com uma boa anamnese e exame físico cuidadoso, somos capazes de diagnosticar grande parte das causas de abdome agudo.

4.1 ANAMNESE

As características da dor, tais como: localização, irradiação, duração, intensidade, os fatores que melhoram ou pioram a dor; bem como os sintomas associados e a história patológica pregressa, são importantes e ajudam-nos a fazer o diagnóstico etiológico da dor abdominal. Mais adiante, estudaremos detalhadamente cada patologia que cursa com abdome agudo e suas particularidades.

Veja esta figura, apenas para você ir familiarizando-se com as diversas causas de dor abdominal, cirúrgicas e não cirúrgicas:

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Causa da dor abdominal de acordo com a localização

4.2 EXAME FÍSICO

O exame abdominal inclui inspeção, ausculta, percussão e palpação. É importante verificar sinais de peritonite, como a descompressão brusca dolorosa e a defesa muscular involuntária. Na ausculta podemos encontrar ruídos diminuídos no abdome agudo inflamatório, e aumentados com timbre metálico no abdome agudo obstrutivo.

Não esquecer de examinar as regiões inguinais à procura de hérnias, causa de abdome agudo obstrutivo, e fazer o exame de toque retal, pois através dele podemos diagnosticar uma neoplasia colorretal baixa, fecaloma e até um abdome agudo perfurativo (crepitação em fundo de saco posterior é indicativo de perfuração de víscera oca retroperitoneal). A maioria dos autores, inclusive o Sabiston, defendem que o exame retal é mandatório em todo o paciente com dor abdominal aguda.

Um exame ginecológico completo deve ser realizado em mulheres em idade fértil, com queixa de dor pélvica e muitas vezes é o suficiente para que se faça o diagnóstico diferencial de um abdome agudo inflamatório.

É muito comum cair em provas de Residência alguns sinais físicos encontrados em pacientes com dor abdominal aguda e que nos orienta no diagnóstico. Coloquei aqui os que mais caem nas provas e que você precisa saber, mas, em nosso livro texto, esta tabela está mais completa.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Sinal	Descrição	Causa
Sinal de Blumberg	Dor à descompressão brusca na fossa ilíaca direita, no ponto de McBurney.	Apendicite aguda
Sinal Lapinsky	Dor no quadrante inferior direito com extensão passiva do quadril ipsilateral.	
Sinal do Iliopsoas	Dor à extensão do quadril direito com o paciente em decúbito lateral esquerdo.	
Sinal de Rovsing	Dor no quadrante inferior direito com palpação no quadrante inferior esquerdo (deslocamento retrógrado dos gases).	
Sinal do Obturador	Dor hipogástrica com a flexão da coxa, seguida de rotação interna do quadril direito.	
Sinal de Lenander	Diferença de temperatura axilar e retal em torno de 1º C (retal > axilar).	
Sinal de Chutro	Desvio da cicatriz umbilical para a direita.	
Sinal de Aaron	Dor sentida no epigástrio ou precórdio quando se pressiona o ponto de McBurney ou a fossa ilíaca direita.	
Sinal de Ten Horn	Dor em fossa ilíaca direita, causada por tração suave do testículo direito.	
Sinal de Dunphy	Dor em fossa ilíaca direita que piora com a tosse.	
Sinal de Summer	Hiperestesia cutânea em fossa ilíaca.	
Sinal de Markle	Dor no peritônio parietal quando o paciente na ponta dos pés choca os calcanhares contra o chão.	Irritação peritoneal
Sinal de Lopez-Cross	Semiereção peniana em crianças presente nos casos de irritação peritoneal.	
Sinal de Bassler	Dor ao comprimir o apêndice entre a parede abdominal e o ilíaco.	Apendicite crônica
Sinal de Murphy	Interrupção abrupta da inspiração profunda durante palpação do hipocôndrio direito.	Colecistite aguda

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
5.0 EXAMES COMPLEMENTARES

5.1 EXAMES LABORATORIAIS

Não existe uma rotina específica de exames laboratoriais no abdome agudo. Eles podem fornecer pistas ao diagnóstico ou excluírem outros diferenciais, mas devem ser solicitados de acordo com nossa suspeita clínica.

Hemograma: fornece várias informações, como leucocitose com desvio à esquerda nos processos infecciosos, anemia no abdome agudo hemorrágico, alteração das hemácias (anemia falciforme), pancitopenia (leucemia). Lembre-se de que idosos e imunocomprometidos podem não alterar os glóbulos brancos e que as gestantes apresentam uma leucocitose fisiológica (é comum apresentarem leucocitose de 15-16.000 células/µL).

Glicose, ânion-gap e cetonemia: cetoacidose diabética (causa de dor abdominal não cirúrgica).

Amilase: elevações nas concentrações séricas de amilase não são sensíveis nem específicas para pancreatite e podem indicar um processo mais ameaçador, como isquemia mesentérica ou perfuração intestinal. Valores normais de amilase não excluem o diagnóstico de pancreatite aguda, pois, em até 20% dos pacientes com pancreatite alcoólica, há uma incapacidade do parênquima em produzir amilase e em pacientes com hipertrigliceridemia, os triglicerídeos aumentados podem interferir no método laboratorial pelo qual a amilase é dosada (cerca de metade dos doentes).

Lipase: é mais sensível e específica do que a amilase para pancreatite, principalmente se a elevação for três ou mais vezes o valor considerado normal.

Bilirrubinas, fosfatase alcalina e transaminases: aumentadas nas obstruções das vias biliares e doenças hepáticas.

Ureia, creatinina e eletrólitos: uremia, desidratação.

BHCG: deve ser solicitado para mulheres em idade fértil com dor abdominal. Sempre positivo na gravidez ectópica.

Urina I (EAS): avaliar leucocitúria, bacteriúria (infecções urinárias, mas pode estar presente nas apendicites pélvicas), hematúria (nefrolitíase).

Lactato e gasometria arterial: auxiliam no diagnóstico da isquemia mesentérica.

5.2 EXAMES DE IMAGEM

Os exames radiológicos só devem ser solicitados se a história clínica, o exame físico e até mesmo os exames laboratoriais não fecharem o diagnóstico. Devem ser solicitados de acordo com a suspeita clínica, pois não existe um “melhor exame” para todo “abdome agudo”.

RADIOGRAFIA SIMPLES

A rotina radiológica de abdome agudo, comumente, é o primeiro exame de imagem a ser realizado, por ser de baixo custo e com alta disponibilidade. É um exame simples, barato e útil na avaliação do abdome agudo, principalmente quando houver suspeita de **OBSTRUÇÃO INTESTINAL e PERFURAÇÃO INTESTINAL**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



ROTINA RADIOLÓGICA DE ABDOME AGUDO

Radiografia de tórax póstero-anterior (PA) em pé (ortostase).

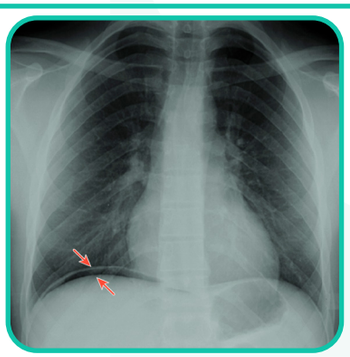
Radiografia de abdome em pé e deitado (decúbito dorsal).

As principais alterações radiológicas que podemos encontrar no abdome agudo são:

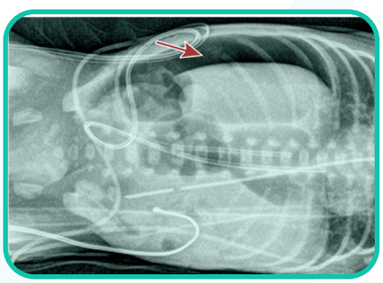
ABDOME AGUDO PERFURATIVO

PNEUMOPERITÔNIO: visualizado como ar sob o diafragma, presente na perfuração de víscera oca, sendo a causa mais comum a úlcera péptica perfurada. Está presente em até 75% das úlceras duodenais perfuradas. É possível detectar 1 ml de ar livre na cavidade.

A ausência de pneumoperitônio não exclui o diagnóstico de abdome agudo perfurativo.





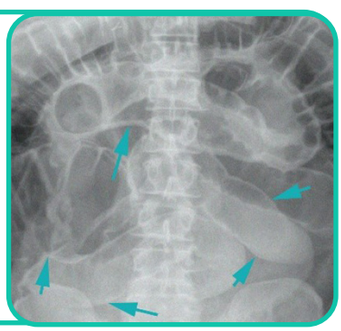


Pneumoperitônio



SINAL DE RIGLER

Também conhecido como sinal da dupla parede, é um sinal radiológico que se refere à visualização, na radiografia de abdome, da parede gástrica ou intestinal devido à presença de gás na cavidade abdominal (pneumoperitônio).



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO

A radiografia simples de abdome é muito útil, pois permite diferenciar as obstruções de intestino delgado das obstruções de intestino grosso.



Obstrução intestinal alta:

- Distensão gasosa intestinal e níveis hidroaéreos.
- Visualização das pregas coniventes, chamada de “empilhamento de moedas”.
- Distribuição mais centralizada no abdome.
- Pouco ar nos cólons.
- Clinicamente, o paciente apresenta vômitos precoces e biliosos.



Obstrução intestinal alta: distensão de delgado, empilhamento de moedas e níveis hidroaéreos.
Fonte: Shutterstock



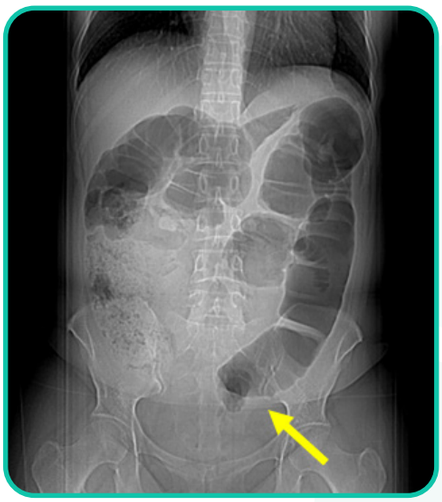


Níveis hidroaéreos
Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva

Obstrução intestinal baixa:

- Distensão colônica, com visualização das haustrações colônicas.
- Localização mais periférica no abdome.
- Ausência de ar na ampola retal.
- Válvula ileocecal competente: obstrução em alça fechada e a distensão gasosa limita-se ao cólon.
- Válvula incompetente: distensão de intestino delgado e, provavelmente, o paciente apresentará vômitos fecaloides tardios.
- Volvo de sigmoide: “sinal do grão de café” ou “sinal do U invertido”.
- Fecaloma: imagem de “miolo de pão”.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Obstrução de cólon em alça fechada: distensão colônica com "stop" gasoso no retossigmoide e ausência de ar na ampola retal.
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



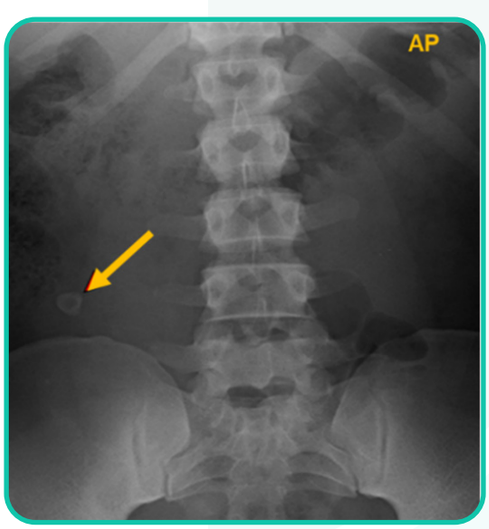
Fecaloma: imagem em "miolo de pão"



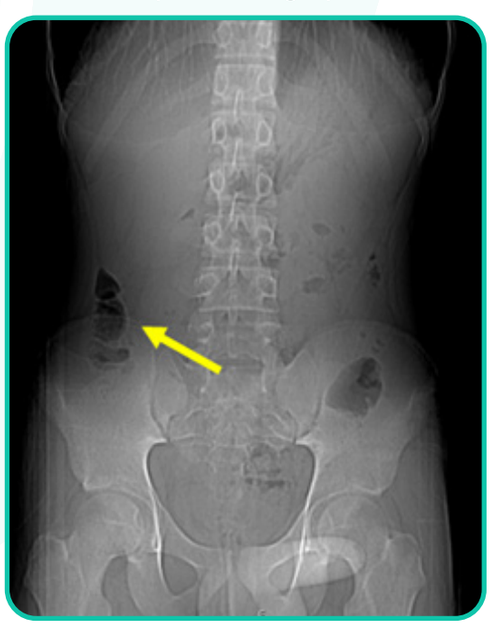
Volvo de sigmoide: Imagem do "Grão de café".
Fonte: Prova de acesso direto do HPM MG 2020

OUTRAS ALTERAÇÕES:

- Apendicite aguda: apendicolito ou fecalito (5% a 10% dos casos); alça sentinela em quadrante inferior direito, apagamento do músculo psoas à direita.
- Íleo biliar e colangite enfisematosa: aerobilia ou pneumobilia.
- Sinal de amputação de cólon (cut-off): consiste na dilatação do cólon transverso até a flexura esplênica, sugestivo de pancreatite aguda.
- Corpos estranhos.
- Calcificações na pancreatite crônica.
- Cálculos renais: 85% a 90% são radiopacos e visíveis na radiografia simples de abdome.
- Cálculos biliares: 10% são radiopacos. Inclusive, na obstrução intestinal por íleo biliar, pode ser visto o cálculo no quadrante inferior direito, associado a um padrão radiológico de obstrução intestinal e aerobilia (tríade de Rigler).



Fecalito e apagamento do músculo Psoas direito.
Fonte: imagem adaptada do UpToDate



Alça sentinela.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

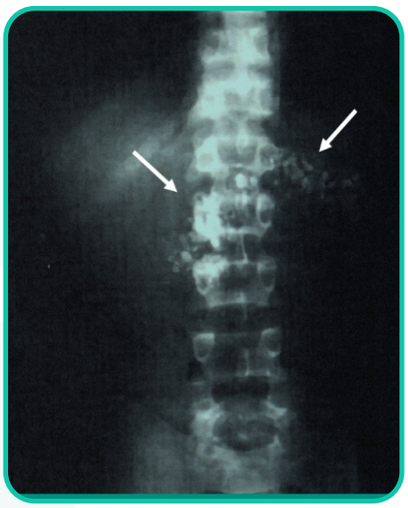
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Ingestão de corpo estranho.
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



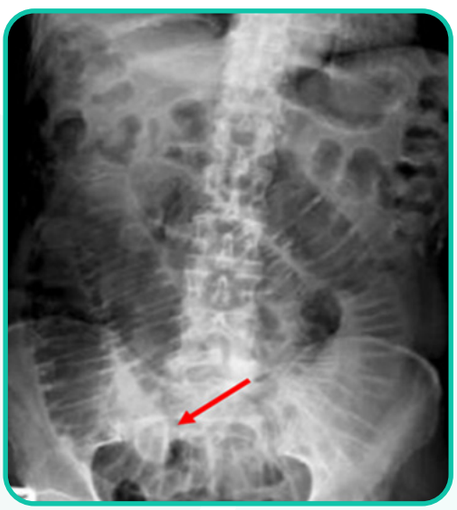
Introdução de corpo estranho retal
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



Pancreatite crônica: calcificações pancreáticas



Colelitíase.
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



Íleo biliar: Cálculo ectópico e obstrução intestinal alta.
Fonte: Prova de acesso direto - FAMEMA 2020

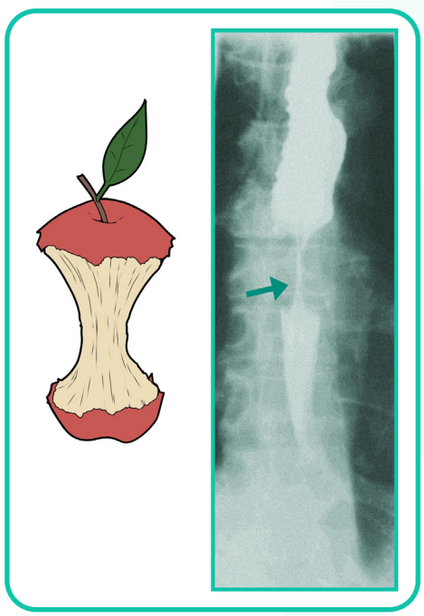


Aerobilia

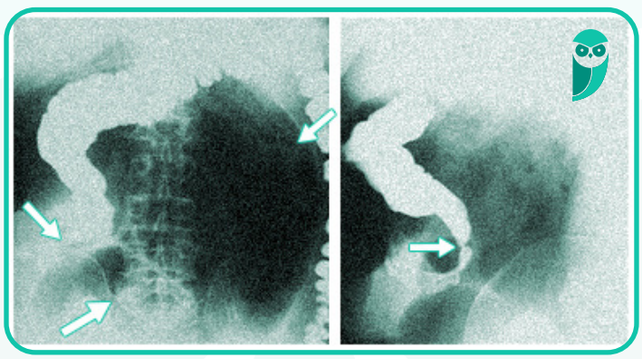
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ENEMA

O enema não é um exame rotineiramente realizado, mas pode trazer algumas informações úteis em alguns casos. Algumas imagens contrastadas são típicas:



Neoplasia colorretal: Sinal da "Maçã mordida".



Volvo: Imagem do "bico de pássaro".
Fonte: imagem adaptada UpToDate



Doença diverticular do cólon sigmoide.
Fonte: Shutterstock

ULTRASSONOGRAFIA

- Vantagens: exame não invasivo, sem radiação, de baixo custo, rápido, que pode ser realizado na beira do leito de pacientes graves e instáveis.
- Desvantagens: examinador dependente, limitado diante de distensão gasosa intestinal, em pacientes obesos, na detecção de pneumoperitônio e processos retroperitoneais.
- Exame de escolha em gestantes e crianças.
- Exame inicial de escolha para o diagnóstico de colecistite aguda.
- Ultrassom transvaginal: útil na avaliação de patologias pélvicas ginecológicas, comum em mulheres jovens em idade fértil. Exemplos: torção ovariana, abscesso tubo-ovariano, prenhez ectópica rota.

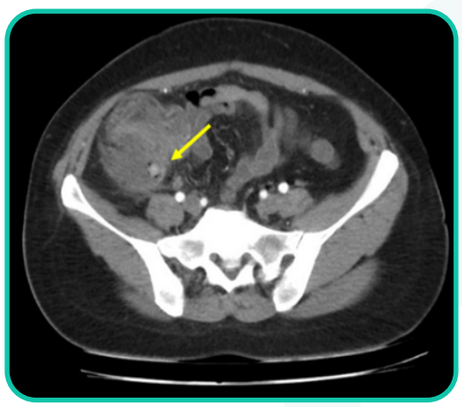
TOMOGRAFIA

- Exame de escolha na avaliação da dor abdominal aguda, mas só deve ser realizada quando não fechamos o diagnóstico com história clínica e o exame físico.
- Requer estabilidade hemodinâmica.
- Particularmente útil em idosos, imunocomprometidos, obesos, em que os sintomas podem ser mais frustros.

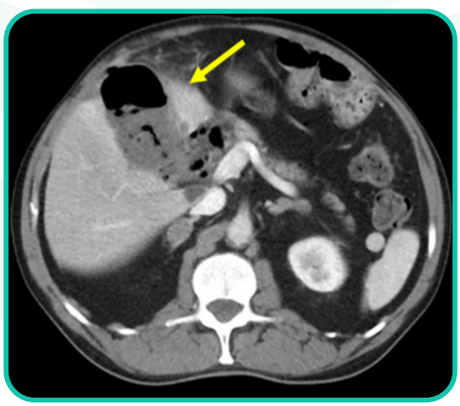
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Diversos são os diagnósticos possíveis com o uso da tomografia: apendicite, colecistite, colangite, diverticulite aguda, abdome agudo perfurativo, aneurisma de aorta, isquemia mesentérica (angiotomografia), pancreatite e suas complicações, dentre outras. Você verá mais adiante que a tomografia, além de ser diagnóstica, é extremamente importante para que se defina a conduta terapêutica, como nos casos de apendicite complicada com abscesso, em que é possível fazer um tratamento inicial conservador, com punção da coleção e programação da apendicectomia de intervalo e na diverticulite aguda, com a classificação de Hinchey, usada para auxiliar na escolha do tratamento.

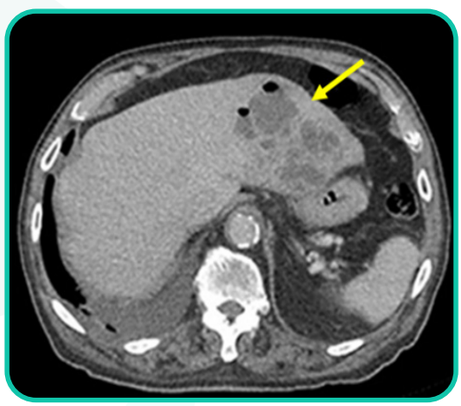
Alguns exemplos:



Apendicite aguda complicada

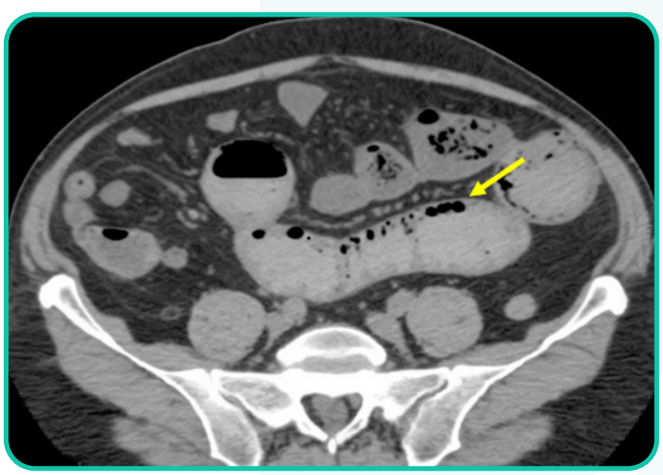


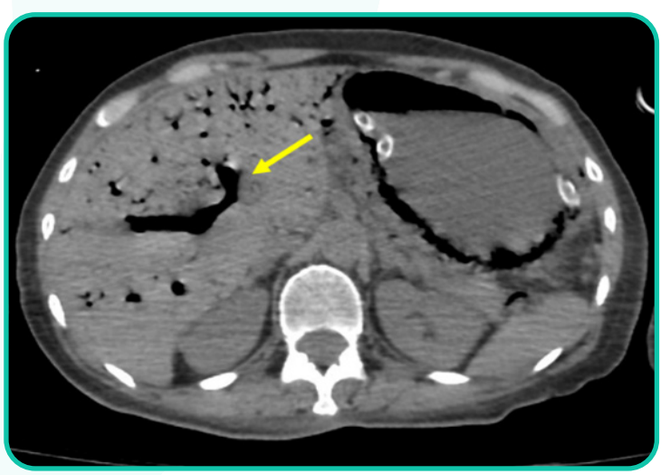
Colecistite enfisematosa



Abscesso hepático

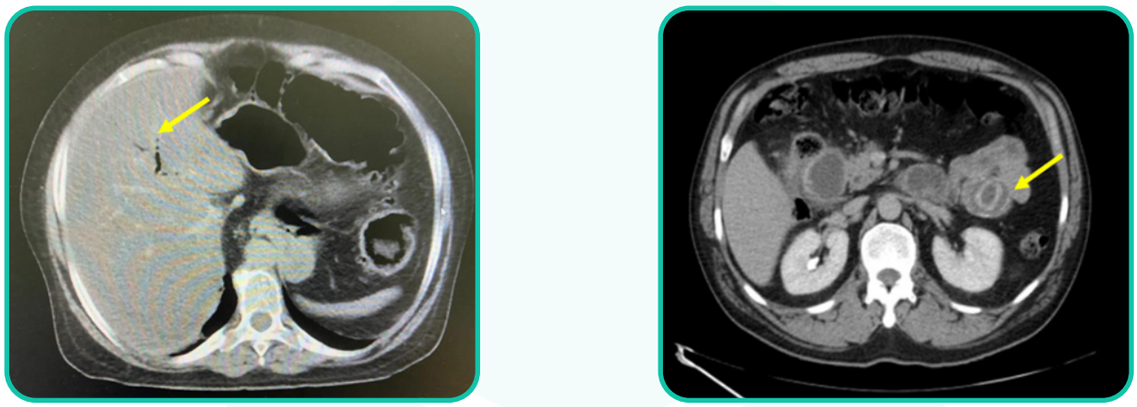
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.





Isquemia mesentérica (pneumatose intestinal e gás portal).
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



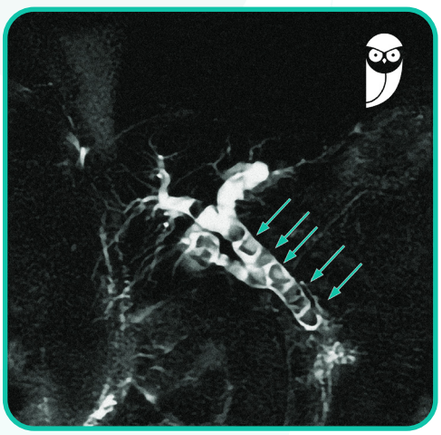
Íleo Biliar: aerobilia e cálculo impactado no delgado.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)

Principais indicações: gestante com suspeita de apendicite aguda com ultrassonografia inconclusiva e nas obstruções da via biliar (colangiorressonância). Também é muito útil para o diagnóstico de endometriose pélvica.

Desvantagens: alto custo, baixa disponibilidade, é um exame demorado,

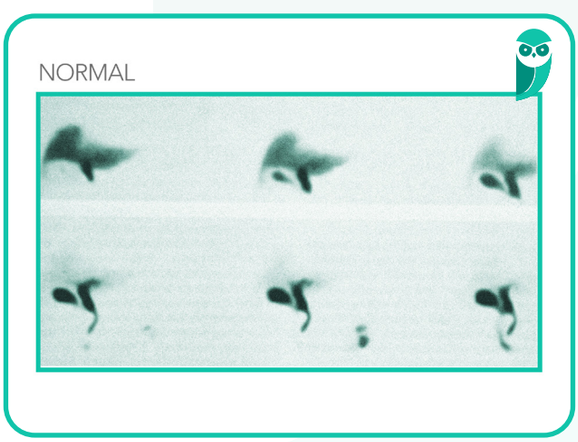
Contraste: gadolínio, considerado mais seguro que o contraste iodado da tomografia.

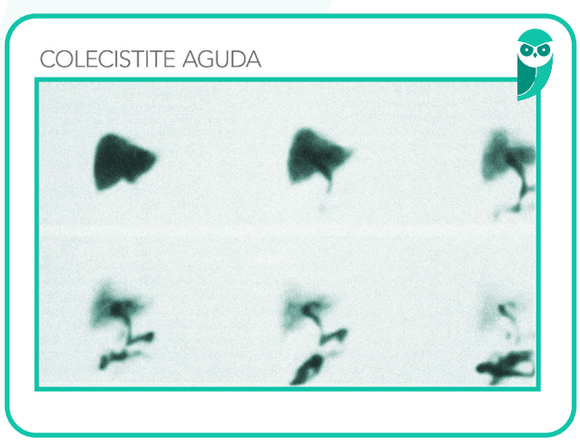


Coledocolitíase.
Fonte: imagem adaptada do UpToDate.

OUTROS EXAMES

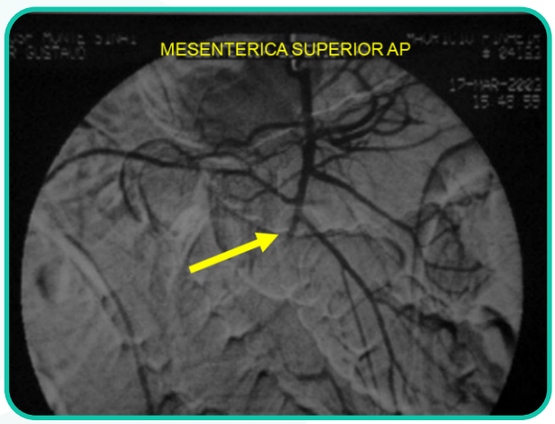
Cintilografia: padrão-ouro para o diagnóstico de colecistite aguda, em que a vesícula biliar inflamada não é visualizada.





Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Angiografia: diagnóstico e terapêutica em alguns quadros de isquemia mesentérica. No entanto, a angiotomografia vem ganhando espaço por ser menos invasiva que a angiografia.



Isquemia mesentérica: oclusão da artéria mesentérica superior
Fonte: Prova de acesso direto SUPREMA MG 2020

LAPAROSCOPIA

Se ainda persistir dúvida, podemos lançar mão da laparoscopia, que, além de diagnóstica, é terapêutica para a maioria das causas de abdome agudo.

A laparoscopia é a via cirúrgica preferencial em gestantes.

Está contraindicada na presença de instabilidade hemodinâmica.

CAPÍTULO
6.0 CAUSAS DE ABDOME AGUDO

O que considero mais importante é definir se o abdome agudo é cirúrgico ou não e, principalmente, sua gravidade.

6.1 ABDOME AGUDO CIRÚRGICO

São cinco os tipos de abdome agudo: inflamatório, obstrutivo, perfurativo, vascular e hemorrágico. Nesta tabela há uma lista com as principais patologias de cada abdome agudo.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAUSAS CIRÚRGICAS DE ABDOME AGUDO
Inflamatório (mais frequente)
Apendicite
Colecistite
Colangite
Diverticulite
Abscesso hepático
Abscesso de psoas
Obstrutivo
Bridas
Neoplasias colorretal
Volvo de sigmoide e de ceco
Hérnia encarcerada
Íleo biliar
Intussuscepção
Doença inflamatória intestinal
Perfurativo
Úlcera gastrointestinal
Divertículo perfurado
Neoplasias perfuradas
Síndrome de Boerhaave
Perfuração intestinal por corpo estranho
Vascular
Isquemia mesentérica (embolia/trombose)
Colite isquêmica
Hérnia estrangulada
Torção ovariana
Torção testicular
Doença de Buerger ou tromboangeite obliterante (TAO)
Hemorrágico
Aneurisma de aorta roto
Gravidez ectópica rota
Cisto ovariano roto
Ruptura esplênica
Pancreatite hemorrágica

Fonte: Sabiston 20ª edição.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Vou resumir para você os principais sintomas de cada tipo de abdome agudo:

ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO: apendicite aguda é a causa mais comum. Geralmente apresenta febre e leucocitose. No exame físico, é comum ter sinais de irritação peritoneal, como descompressão brusca dolorosa e defesa muscular involuntária. Os ruídos hidroaéreos geralmente estão diminuídos. Pacientes com peritonite tendem a ficar quietos e imóveis.

ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO: as bridas são a principal causa de abdome agudo obstrutivo e estão relacionadas à cirurgia abdominal prévia. Clinicamente, apresenta dor e distensão abdominal, vômitos (precoces na obstrução alta e fecaloides na obstrução baixa), parada de eliminação de fezes e flatos. Ao exame físico, há timpanismo à percussão e os ruídos estão aumentados, com timbre metálico (peristaltismo de luta).

ABDOME AGUDO PERFURATIVO: a principal causa é a úlcera péptica perfurada, sendo que a úlcera que mais perfura é a da parede anterior do bulbo duodenal. Clinicamente, apresenta-se com dor epigástrica súbita de forte intensidade que logo se irradia para todo o abdome. Ao exame físico, o abdome está tenso, em tábua, com sinais de peritonite difusa. À percussão, o sinal de Jobert é positivo, ou seja, há presença de hipertimpanismo ao invés da macicez da loja hepática. O diagnóstico é feito com a visualização do pneumoperitônio nos exames de imagem. O tratamento é cirúrgico de urgência.

ABDOME AGUDO VASCULAR: ocorre por deficiência na irrigação mesentérica. A causa mais comum é a embolia arterial da artéria mesentérica superior ou de seus ramos que acomete, principalmente, pacientes com fatores de risco como IAM recente e fibrilação atrial. A segunda causa mais comum é a obstrução arterial por trombose, comum em arteriopatias com relato de doença coronariana, insuficiência arterial periférica ou acidente vascular cerebral prévios. Clinicamente, manifesta-se com dor abdominal difusa de forte intensidade, com exame físico desproporcional à intensidade da dor, ou seja, geralmente o abdome é flácido e sem sinais de peritonite. O diagnóstico é feito com a angiotomografia ou arteriografia (padrão-ouro). O tratamento dependerá da causa e do tempo de evolução, sendo que a presença de sinais de isquemia avançada (peritonite, pneumatose intestinal e gás no sistema portal) indica laparotomia de urgência.

ABDOME AGUDO HEMORRÁGICO: como exemplos, podemos citar o aneurisma de aorta roto, gravidez ectópica rota e a ruptura esplênica. Além da dor abdominal, é comum apresentar sinais de choque hipovolêmico, como taquicardia, hipotensão e taquipneia. Na percussão, podemos encontrar macicez móvel (sangue livre na cavidade).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Nesta outra tabela, retirada da 20ª edição do Sabiston, estão alguns achados clínicos, radiológicos e laboratoriais que sugerem uma patologia cirúrgica.

ACHADOS ASSOCIADOS À DOENÇA CIRÚRGICA NO CONTEXTO DE DOR ABDOMINAL AGUDA	
Exame físico e achados laboratoriais	Pressão compartimental abdominal > 30 mmHg
	Distensão piora após a descompressão gástrica
	Defesa involuntária ou sensibilidade de rebote
	Hemorragia gastrointestinal, exigindo > 4 u de sangue sem estabilização
	Sepse sistêmica inexplicada
	Sinais de hipoperfusão (p. ex., acidose, dor desproporcional aos achados do exame, aumento dos resultados de função hepática)
Achados radiográficos	Dilatação intensa do delgado
	Dilatação progressiva da alça estacionária do intestinal (alça sentinela)
	Pneumoperitônio
	Extravasamento de contraste do lúmen intestinal
	Oclusão vascular na angiografia
	Gordura espessada, parede intestinal espessada com sepse sistêmica
Lavagem peritoneal diagnóstica (1000 ml)	> 200 leucócitos por mililitro aspirado
	> 300.000 hemácias por mililitro aspirado
	Nível de bilirrubina maior do que o nível plasmático no aspirado (vazamento de bile)
	Presença de material particulado (fezes)
	Nível de creatinina maior do que o nível plasmático no aspirado (vazamento de urina)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

6.2 ABDOME AGUDO NÃO CIRÚRGICO

Aqui estão listadas algumas patologias que podem cursar com dor abdominal aguda, mas que não exigem tratamento cirúrgico.

CAUSAS NÃO CIRÚRGICAS DE ABDOME AGUDO
Endócrinas e metabólicas
Uremia Cetoacidose Crise addisoniana Porfiria aguda intermitente Febre hereditária do Mediterrâneo
Hematológicas
Crise falciforme Leucemia aguda Outras discrasias sanguíneas
Toxinas e drogas
Envenenamento por chumbo Intoxicação por outros metais pesados Crises de abstinências Envenenamento por aranha viúva-negra

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
7.0 TRATAMENTO DO ABDOME AGUDO

Paciente com dor abdominal aguda, sinais de peritonite difusa e instabilidade hemodinâmica = **LAPAROTOMIA EXPLORADORA!!!** Independentemente da causa do abdome agudo!

O termo "laparotomia" significa a abertura cirúrgica da cavidade abdominal, com a finalidade diagnóstica e/ou terapêutica. A laparotomia mediana (incisão vertical que segue a linha alba) é a que oferece rápido e amplo acesso à cavidade abdominal.

Uma vez diagnosticado um abdome agudo cirúrgico, devemos preparar o paciente para a cirurgia, e isso deve ser feito de maneira rápida e contínua, ou seja, manter no intra e pós-operatório. Essa preparação inclui:

- hidratação venosa;
- correção de distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos;
- antibióticos de largo espectro para Gram-negativos e anaeróbios imediatamente;
- passagem de sonda nasogástrica nos pacientes que apresentam vômitos incoercíveis;
- sondagem vesical para controle da diurese e adequação da reposição volêmica;
- coleta de tipagem sanguínea;
- acesso venoso central e uso de drogas vaso ativas, a depender das condições clínicas do paciente.

Mas, isso tudo não deve postergar a cirurgia no abdome agudo, e sim estabilizar o paciente para oferecer melhores condições à anestesia e ao procedimento cirúrgico, com o intuito de diminuir a morbimortalidade.

CAPÍTULO
8.0 ABDOME AGUDO EM POPULAÇÕES ESPECIAIS

8.1 IDOSOS

A resposta inflamatória no idoso está diminuída, resultando em achados menos notáveis na história e no exame físico. Muitos não apresentam febre, alteração laboratorial e dor, o que acaba retardando o diagnóstico. Devido a essa apresentação atípica, a história clínica e o exame físico podem não ser tão confiáveis, e a tomografia de abdome é um exame valioso no diagnóstico de abdome agudo nesses pacientes.

As causas mais comuns de abdome agudo no idoso são: a obstrução intestinal por neoplasia colorretal, aneurisma de aorta, diverticulite, isquemia mesentérica e colecistite aguda.



A colecistite aguda é a causa mais frequente de cirurgia de urgência no idoso.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

8.2 GESTANTES

A principal causa de abdome agudo cirúrgico não obstétrico na gestante é a apendicite aguda (1:1.500 gestações). A segunda causa é a colecistite (1-6: 10.000), sendo a ultrassonografia o primeiro exame de imagem a ser realizado para o diagnóstico dessas patologias. A terceira causa seria a obstrução intestinal (1-2:4.000), geralmente por aderências intestinais (2/3 dos casos) e volvo de sigmoide (25% dos casos).

A laparoscopia é a via de acesso cirúrgico preferencial na gestante com abdome agudo.

CAPÍTULO
9.0 PERITONITES

9.1 PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA

PBE: infecção do líquido ascítico sem uma fonte evidente, não passíveis de tratamento cirúrgico. A grande maioria dos pacientes com PBE apresenta cirrose avançada e a causa geralmente é por translocação bacteriana. Os sinais e sintomas mais comuns são febre, dor e sensibilidade abdominal e alteração do estado mental (encefalopatia hepática).



DIAGNÓSTICO PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA

- Contagem de PMN* no líquido ascítico ≥ 250 células/mm3.
- Cultura positiva monobacteriana (*E. coli* – mais comum).
- Exclusão de causas secundárias de peritonite.
- Tratamento com antibioticoterapia.

9.2 PERITONITE BACTERIANA SECUNDÁRIA

As infecções tratáveis cirurgicamente, por exemplo, uma úlcera duodenal perfurada, que levam à infecção pelo líquido ascítico, são chamadas de peritonite bacteriana secundária, polimicrobiana, representadas principalmente pelos microrganismos da flora do trato gastrointestinal, ou seja, bactérias Gram-negativas entéricas e anaeróbias.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PERITONITE QUÍMICA

Nas perfurações altas, como, por exemplo, as causadas pela úlcera péptica, os sucos digestivos que extravasam, levam a uma **peritonite química**, seguido de proliferação bacteriana e consequente processo infeccioso. Nas perfurações baixas do trato digestivo, a peritonite é infecciosa desde o início, evoluindo rapidamente de um quadro focal para um sistêmico. Então, até 12 horas da perfuração gástrica/duodenal, há uma reação inflamatória do peritônio com produção de exsudato inflamatório. Após esse período, há contaminação bacteriana e desenvolvimento de peritonite bacteriana secundária.

PBE X PBS

A peritonite bacteriana secundária (PBS) é uma infecção do líquido ascítico em que existe uma cultura multibacteriana positiva e uma contagem de polimorfonucleares (PMN) do líquido ascítico ≥ 250 células/mm³ no cenário de uma fonte intra-abdominal de infecção tratável cirurgicamente. As causas mais comuns de peritonite secundária são a infecção direta devido à perfuração ou inflamação das vísceras intra-abdominais. A distinção entre PBS e PBE é crucial, porque a primeira geralmente requer antibióticos e tratamento cirúrgico, enquanto a segunda requer apenas antibióticos. A distinção é baseada principalmente na análise do líquido ascítico, estudos de imagem e resposta ao tratamento.

Além da cultura aeróbia e anaeróbia, a contagem e diferencial de células, para apoiar o diagnóstico ou diferenciar a PBE da peritonite bacteriana secundária, podemos solicitar mais alguns exames no líquido ascítico:

Parâmetros	PBE	PBS
Cultura e Gram	Monobacteriana	Polibacteriana
Proteína total	< 1 g/dL	> 1 g/dL
Diferença albumina sérica e ascítica	> 1,1g/dL (hipertensão portal)	
Glicose	> 50 mg/dL (2,8 mmol / L)	< 50 mg / dL (2,8 mmol/L)
LDH	Pouco aumentada	> limite superior do soro
Amilase	Valor normal: +/- 42 ui/L	> 5x o valor sérico na ascite pancreática
Bilirrubina	Valor normal: +/- 0,7 mg/dL	> 6 mg/dL (coleperitônio)
CEA e FA.		CEA > 5; FA > 240 = perfuração intestinal

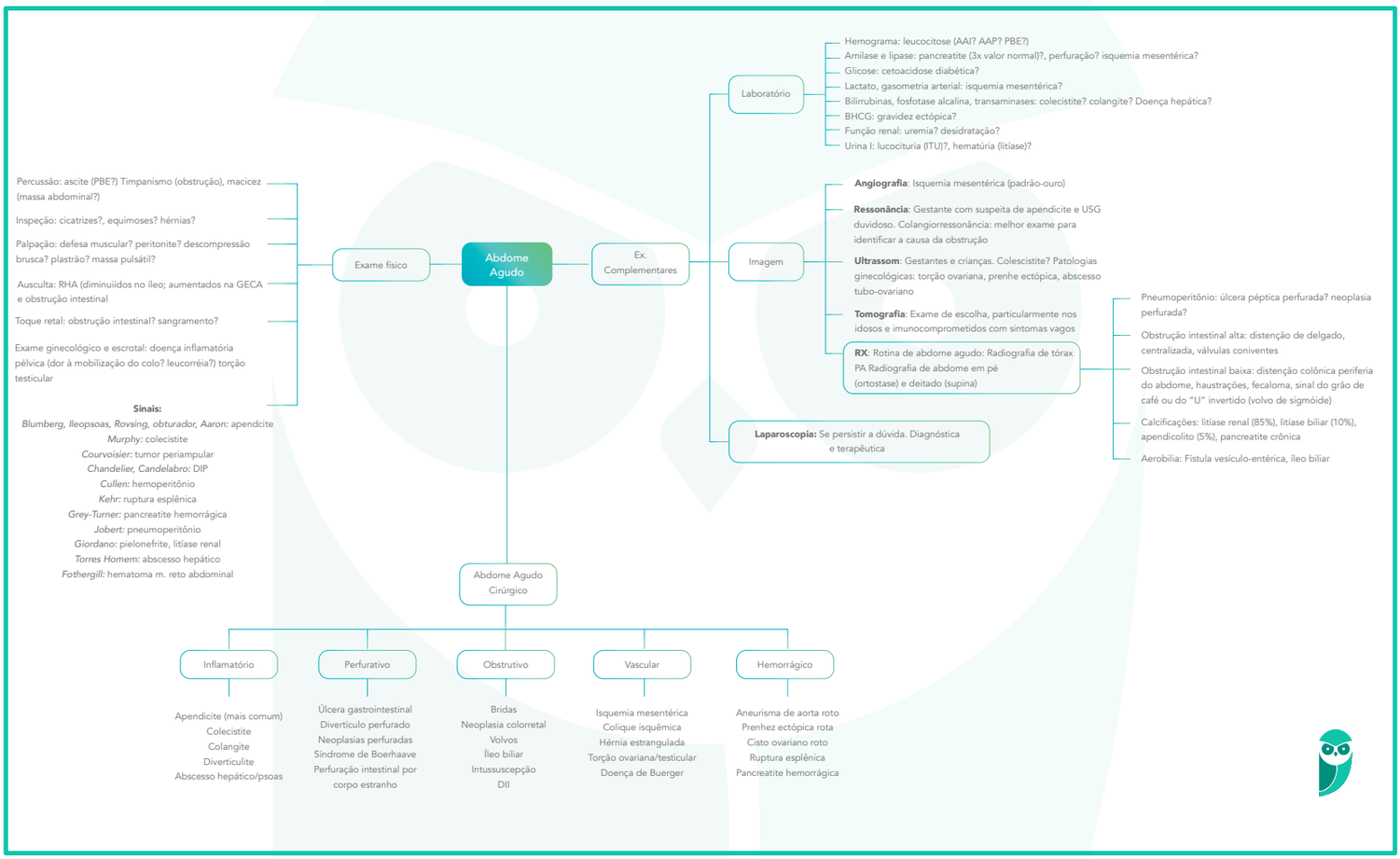
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

9.3 PERITONITE BACTERIANA TERCIÁRIA

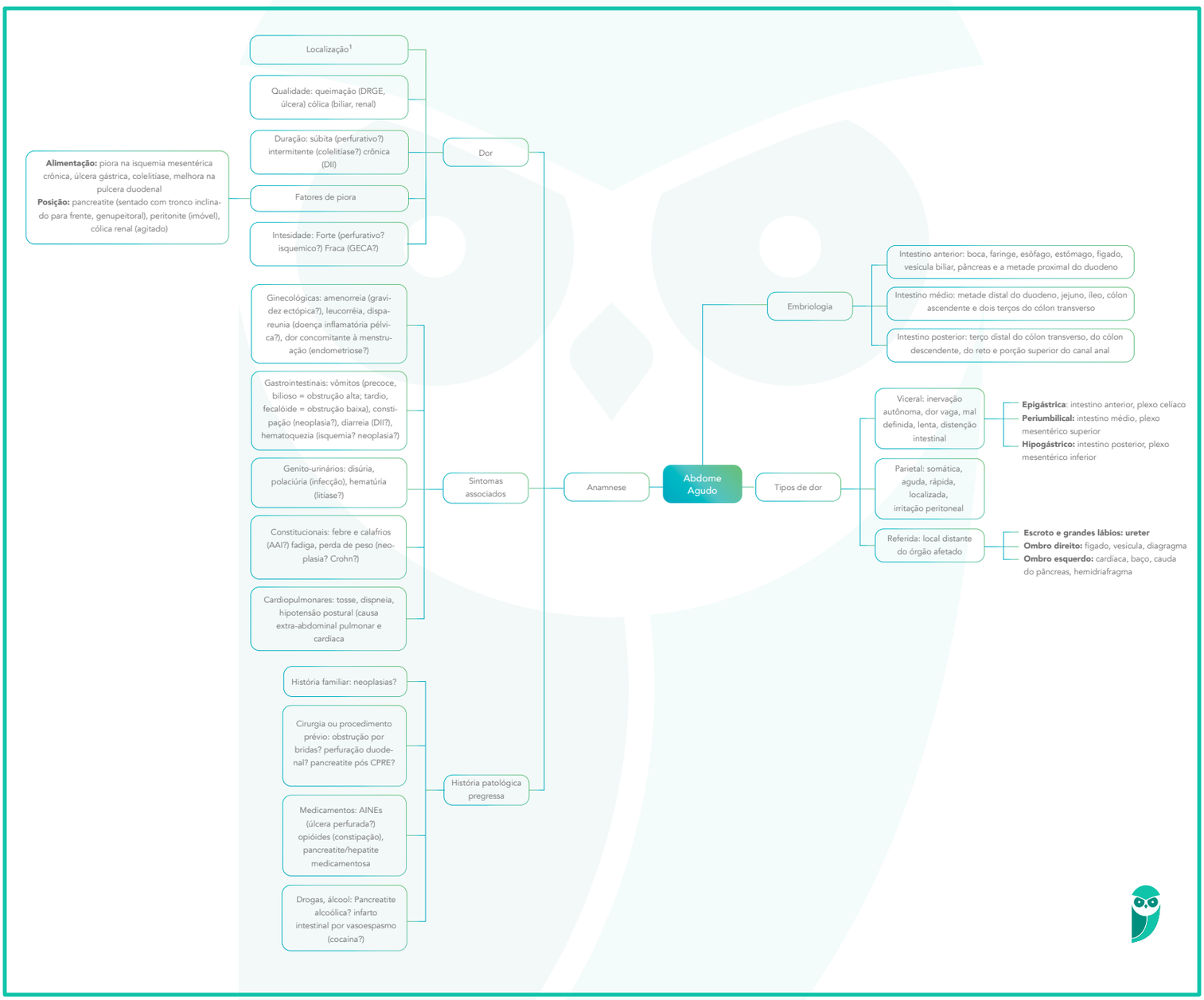
- Infecção peritoneal persistente ou recorrente após a intervenção médica, clínica ou cirúrgica, para o tratamento da peritonite secundária.
- Falha na defesa do organismo e no controle do processo infeccioso.
- Geralmente, é consequência de infecção por bactérias não patogênicas ou atípicas, multirresistentes e fungos, que podem não ser revelados em análises microbiológicas por métodos usuais, o que torna o tratamento um desafio.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
10.0 MAPA MENTAL



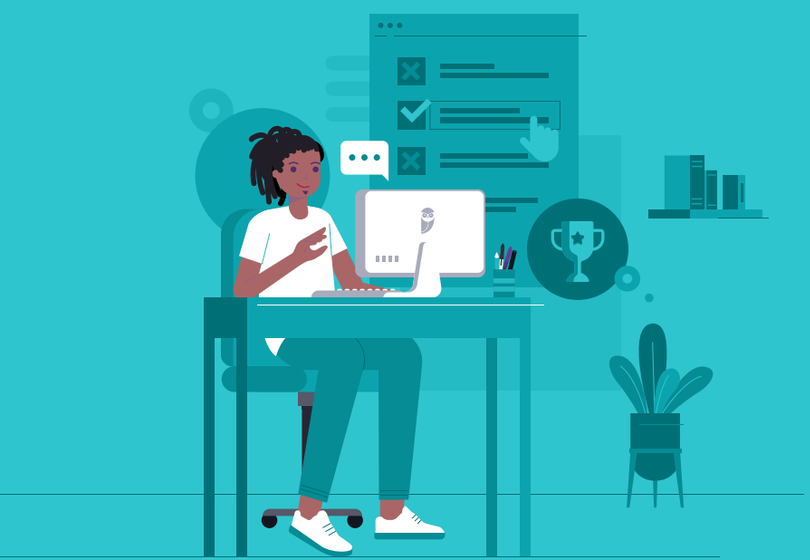
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://bit.ly/3uirV1y

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

12.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20ª edição

Uptodate:

1. Avaliação do adulto com dor abdominal
2. Causas de dor abdominal em adultos
3. Avaliação de emergência da criança com dor abdominal aguda
4. Patogênese da peritonite bacteriana espontânea
5. Peritonite bacteriana espontânea em adultos: manifestações clínicas
6. Peritonite bacteriana espontânea em adultos: diagnóstico
7. Peritonite bacteriana espontânea em adultos: tratamento e profilaxia

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
13.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido Aluno, sei que esse tema não é dos mais agradáveis, por ter muitos conceitos e ser abrangente demais. Mas, ele será a base para você compreender melhor todas as patologias abdominais que discutiremos nos próximos capítulos.

Sei que o assunto é um pouco complexo e é normal que haja dúvidas. Então, caso você não tenha entendido bem algum tópico, estou à disposição para responder a você no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED.

Bons estudos e fique com Deus!

Abraços,

Renatha Paiva

@estrategiamed

@prof.renathapaiva

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina